



CDC: Child Dissociative Checklist

Escala de Disociación en Niños (5 a 11 años)

(V.3.0 – 2/90)

Frank W. Putnam, M.D. – Unit on Dissociative Disorders, LDP, NIMH

A ser completado por el terapeuta:

Fecha:

/ /

Puntaje CDC:

Nombre de la persona que
completa este cuestionario:

Relación con el niño a evaluar:

☐

Padre/
Madre

☐

Padrastra/
Madrastra

☐

Profesor

☐

Otro

Nombre del niño/a a evaluar:

Fecha de nacimiento niño/a:

/ /

Sexo:

☐

Masculino

☐

Femenino

CDC

Child Dissociative Checklist

Escala de Disociación en Niños

(V.3.0 – 2/90)

Frank W. Putnam, M.D. – Unit on Dissociative Disorders, LDP, NIMH

INSTRUCCIONES

A continuación, hay una lista de conductas infantiles. Por cada una de ellas que presente su hijo/a **AHORA** o haya presentado **DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES**, por favor marque:

2 si el ítem es **VERDADERO** para su hijo/a.

1 si es **VERDADERO A VECES**.

0 Si el ítem **NO ES VERDADERO** para su hijo/a

1	El niño/a no recuerda o niega experiencias traumáticas o dolorosas que se sabe que han sucedido.	0	1	2
2	Por momentos entra en estados tipo trance o suele aparecer "como en las nubes". Las maestras pueden informar que él/ella frecuentemente está en estado de ensoñación en la escuela.	0	1	2
3	Muestra rápidos cambios en su personalidad. Él/ella puede pasar de ser cauteloso/a a excederse, de ser femenino/a a masculino/a, de tímido/a a agresivo/a.	0	1	2
4	Se muestra inusualmente a olvidadizo/a o confuso/a acerca de cosas que debería saber, como por ejemplo, olvidarse de los nombres de amigos, maestros u otras personas importantes, perder sus cosas o perderse fácilmente.	0	1	2
5	Posee un pobre sentido del tiempo. Pierde el curso del tiempo, puede pensar que es la mañana cuando en realidad es la tarde, se confunde acerca del día que es o aparece confundido/a acerca de cuándo sucedió algo.	0	1	2
6	Muestra marcadas variaciones diarias o incluso de hora en hora en sus habilidades, conocimientos, gustos sobre comidas, habilidades físicas, por ejemplo, cambios en la escritura, en el recuerdo de información previamente aprendida (como las tablas de multiplicar, por ejemplo), ortografía, uso de útiles o habilidades artísticas.	0	1	2
7	Muestra rápidas regresiones en el nivel evolutivo de conductas, por ejemplo, un chico de 12 años empieza a hablar como bebé, se chupa el pulgar o dibuja como si tuviera 4 años.	0	1	2

A ser completado por el terapeuta:

___ + ___ + = _____ (Sumatoria página 1) (Subtotal)

8	Tiene dificultades para aprender de la experiencia; por ejemplo: las explicaciones, el uso de disciplina normal o las penitencias no cambian su conducta.	0	1	2
9	Continúa mintiendo o negando su mala conducta aun cuando la evidencia de la misma es obvia.	0	1	2
10	Se refiere a sí mismo/a en tercera persona (por ejemplo, “él”, “ella”, “suyo/a”) o a veces insiste en ser llamado/a con otro nombre. También puede manifestar que cosas que de hecho le sucedieron a él/ella, le pasaron a otra persona.	0	1	2
11	Cambia rápidamente de quejas físicas tales como -por ejemplo- dolor de cabeza o de estómago; puede quejarse de un dolor de cabeza y al momento parece olvidarse por completo de dicho dolor.	0	1	2
12	Se muestra inusualmente precoz a nivel sexual y puede intentar conductas sexuales inapropiadas para su edad con otros niños o adultos.	0	1	2
13	Sufre heridas o lastimaduras inexplicables o incluso puede -a veces- lastimarse deliberadamente.	0	1	2
14	Manifiesta oír voces que le hablan. Las voces pueden sonar amistosas o enojadas y pueden provenir de “amigos imaginarios” o parecerse a las voces de los padres, de amigos, de maestros.	0	1	2
15	Tiene un amigo o amigos imaginarios muy reales. Puede insistir en que tal/es amigo/s imaginario/s son responsables por cosas que el niño/a ha hecho.	0	1	2
16	Tiene intensas explosiones de rabia, usualmente sin causa aparente y puede desarrollar una inusual fuerza física durante tales episodios.	0	1	2
17	Tiene frecuentes episodios de sonambulismo.	0	1	2
18	Tiene experiencias nocturnas inusuales, por ejemplo, manifiesta que ve “fantasmas” o que suceden cosas de noche de las que no puede dar cuenta (por ejemplo, juguetes rotos, heridas inexplicables)	0	1	2
19	Frecuentemente habla consigo mismo/a; a veces puede usar una voz diferente o discutir consigo mismo/a.	0	1	2
20	Posee dos o más personalidades diferentes y separadas que controlan la conducta del niño/a.	0	1	2

A ser completado por el terapeuta:

____ + ____ + = _____ (Sumatoria página 2) (Subtotal)

+ _____ (Sumatoria página 1) (Subtotal)

= _____ **(Total puntaje CDC)** (Regístralo en la línea superior derecha de la página 1)



CDC: Child Dissociative Checklist

Escala de Disociación en Niños (V.3.0 – 2/90)

-Codificación-

Frank W. Putnam, M.D. – Unit on Dissociative Disorders, LDP, NIMH

CDC

Child Dissociative Checklist

Escala de Disociación en Niños

(V.3.0 – 2/90)

Frank W. Putnam, M.D. – Unit on Dissociative Disorders, LDP, NIMH

El cuadro a continuación muestra los puntajes de corte sugeridos de la escala.

	Edad	Puntaje Medio
Normal	5 - 8	3,2
	9 - 11	2,9
Niños maltratados	5 - 8	10,3
	9 - 11	6,1
Trastorno disociativo de la identidad	5 - 8	24,1
	9 - 11	23,8
Trastorno Disociativo No especificado (TDNE)	5 - 8	21,4
	9 - 11	16,5

Notas de Sandra Baita (Libro “Rompecabezas”, p, 117):

- Es importante considerar que estos puntajes y la validación total de la escala requieren aún de mayor investigación y que no se cuenta con información sobre su validación en países de habla hispana .
- Los resultados de esta escala no son definitivos.
- Un puntaje alto no garantiza que estemos frente a un diagnóstico de un desorden disociativo. Tampoco lo descarta un puntaje bajo.
- El diagnóstico es el resultado de la suma de varios elementos, entre los cuales la escala es solo uno de ellos.
- Estas escalas no son diagnósticas, sino de rastreo, pero han sido reconocidas por su confiabilidad a la hora de detectar manifestaciones disociativas ligadas al trauma. Es sumamente importante recordar que el uso de estas escalas no puede reemplazar nunca a la evaluación clínica. Son un complemento importante, pero nunca tanto como el juicio clínico del profesional que evalúa y atiende al niño/a.
- Se recomienda entregar esta escala a otros adultos que estén en contacto con el niño, como por ejemplo, maestros, ya que por las características propias de las presentaciones disociativas, no sería inesperado encontrarse con puntuaciones y manifestaciones diferentes respecto del mismo niño en ámbitos diversos.
- En caso de poder entregarlo a los maestros se les pide obviar los ítems 17 y 18 por cuanto preguntan por conductas nocturnas a las cuales no pueden tener acceso directo.
- Se puede utilizar los ítems del CDC como preguntas formuladas a los adultos a cargo del niño, si considera éstos no completarían la encuesta.
- **Como regla se suele tomar un puntaje de corte de 12 o superior como indicador de disociación patológica y garantizar una mayor profundización diagnóstica.** No obstante si el puntaje es menor pero el clínico tiene razones para sospechar que se encuentra frente a un niño disociativo, es recomendable profundizar en la evaluación clínica, independiente del resultado obtenido en la escala.